

INMUNOPROTECCIÓN AVANZADA

Calostroterapia Neonatal

Módulo 4: Protocolo Clínico de Ejecución Estricta, Segura y Estandarizada

FASE INICIAL DEL
PROTOCOLO

Fase 1: Preparación Segura del Insumo

PREPARACIÓN SEGURA DEL INSUMO

Calostro Materno Exclusivo

La terapia exige exclusivamente la utilización de calostro fresco crudo procedente de la propia madre del neonato. Debe extraerse de preferencia de forma manual y "al pie de cama" para reducir riesgos de contaminación cruzada o alteración de propiedades.

ORIGEN BIOLÓGICO DIRECTO

Ventana Crítica de 48 a 72 Horas

El proceso debe iniciarse y mantenerse con rigurosidad matemática durante las primeras 48 a 72 horas de vida del recién nacido. Esta ventana de tiempo asegura la concentración máxima de componentes inmunológicos clave (como la sIgA, citocinas y factores de crecimiento).

EFICIENCIA INMUNOLÓGICA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ENFERMERÍA

0.

MILILITROS POR SESIÓN

4

Dosificación y Frecuencia Estricta

El equipo de enfermería debe aplicar una dosis controlada y fraccionada. El volumen total está medido exactamente para no propiciar reflejos de deglución excesiva o broncoaspiración accidental:



0.2 mL por mejilla
Aplicación bilateral
yugal



Cada 3 a 4 horas
Sincronía con reloj de
enfermería

TÉCNICA DE APLICACIÓN CLÍNICA

- ✔ **Higiene Oral Previa Obligatoria:** Ejecutar la administración inmediatamente después de realizar la higiene bucal reglamentaria del neonato. Esto garantiza la remoción de biofilmes patógenos y limpia el campo biológico.
- 🧴 **Uso de Instrumental Estéril:** La aplicación debe realizarse con jeringa estéril de 1 cc o con un aplicador/hisopo que minimice la retención de líquido. Se distribuye uniformemente sin agujas.
- ✚ **Frotado Suave y Localizado:** Impregnar activamente pero con un suave frotado la mucosa yugal interna (carrillos) y las encías del neonato, maximizando el tiempo de contacto celular en la mucosa oral.

ADMINISTRACIÓN TÓPICA VS. ENTERAL

Parámetro Clínico	Calostroterapia Orofaringea	Nutrición Enteral Tradicional
Objetivo Primario	Inmunoprotección biológica y estimulación del MALT	Nutrición, aporte calórico y desarrollo metabólico
Vía de Absorción	Absorción tópica local y celular en mucosa oral	Absorción gastrointestinal a nivel de yeyuno/íleon
Reposogástrico	No NO INTERFIERE mite mantener ayuno estricto	Int INTERRUMPE de motilidad y vaciado digestivo
Mecanismo de Acción	Bloqueo local de receptores ante proliferación de patógenos	Aporte de micro y macronutrientes sistémicos

SEGURIDAD INMUNE

Interacción Linfática Local

Este procedimiento es una técnica de inmunoprotección avanzada que actúa mediante el contacto directo de los anticuerpos maternos (inmunoglobulina A secretora) con las células inmunitarias del tejido linfoide asociado a la faringe (OALT).

Puesto que la absorción y acción ocurren localmente en la mucosa, se evita el llenado estomacal, permitiendo mantener la terapia incluso en pacientes con reposo gástrico estricto sin riesgo de enterocolitis.

